EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93545
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 26-09-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: FLOR MARIA NAVARRETE VALENZUELA			RUN	: 5.306.821-9
F.Nac	: 06-12-1940	Edad	: 83 AÑOS, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: ëUBLE 71			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 422415130		
Fecha Ingreso	: 2024-09-23	Fecha Egreso	: 26-09-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G45.8-OTRAS ISQUEMIAS CEREBRALES TRANSITORIAS Y SINDROMES AFINES

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ACV isquémico cerebeloso izquierdo (SUCA)
2. Sd febril de probable foco respiratorio alto 5/7
3. Aneurismas no rotos ambas ACoP (izquierda mayor derecha)
4. Fibrosis pulmonar crónica severa + secuelas TBC izquierdo con O2 domiciliario
5. Desnutrición calórico-proteica
6. HTA
7. Pre-DM2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

mRS 2 (disnea CF 3-4), con antecedentes descritos, consulta tras presentar en la madrugada del 21.09.24 al levantarse 4 am, sensación giro intenso asociado a vómitos y dolor abdominal, refiere que se comprometió de conciencia, una vez recuperada conciencia se arrastra a su cama y llama a familiar por teléfono. En urgencias, PAS 170, FC 78 (sin ECG al ingreso), sato2 95% (con o2 o ambiental?), HGT 183, la describen quejumbrosa quejándose de mareos y cefalea, sin alteración de conciencia, no describen déficit focal, al examen físico general solo destacaba abdomen doloroso difuso, sin blumberg, resto examen conservado. En laboratorio destaca leucocitosis 19.000 con PCR <5, OC no inflamatoria, TC cerebro + angioTC cuello y cerebro con hipodensidad aguda cerebelosa izquierda (SUCA), destaca aneurismas no rotos en ambas ACoP, izquierdo de mayor tamaño, multilobulado, microangiopatía + hipodensidades lacunares lenticular y talámica derechas antiguas.
Evaluada por neurología en urgencias el 23.09.24, paciente en buen estado general, niega cefalea ni vértigo, logra deglución de alimentos con buena tolerancia, PA 169/85, t 37,7, sato2 95%. hgy 99, al examen físico ectomorfa, RR2T sin soplos, MP+ disminuidos en bases, abdomen excavado blando, no doloroso, edema- TVP-, al examen neurológico vigil, orientada TE, atenta, comprende órdenes, sin disartria ni afasia, PC isocoria reactiva, CV conservado, oculomotilidad N; nistagmus patológico -, simetría facial, pares bajos conservados, M5 en 4 extremidades, tono y rot simétricos, plantares flexores, sensitivo simétricos, leve dismetría izquierda con DDC + izquierda, no evalúo marcha por ahora.
Paciente evoluciona de forma favorable, sin déficit focal neurológico, mínima ataxia marcha, sin embargo, presenta fluctuación en condición pulmonar basal con mayor disnea y uso musculatura accesoria corregida con uso inhaladores y O2 persistente, pese a SatO2 ambiental 95%. Se discute con hijos importancia de cuidados ambulatorios, no puede vivir sola, adulto mayor con alto riesgo de comorbilidades, caídas con desnutrición asociada.
Indico alta con HODOM para completar ATB y rehabilitación kinésica pulmonar.

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO, MOVILZIAR POR EQUIPO REHABILITACIÓN, ASISTIDA
2. REGIMEN COMÚN HIPOSÓDICO, EVALUAR PREVIO ALTA CON NUTRICIONISTA
3. ASPIRINA 100 MG VO DIA
4. ATORVASTATINA 40 MG VO DIA
5. PARACETAMOL 1 GR VO SOS
6. LOSARTAN 50 MG VO C/12 HRS
7. CEFTRIAXONA 2 GR EV DIA (5/7)

8. PREDNISONA 10 MG VO DIA AM
9. BROMURO IPRATROPIO 2 PUFF C/8 HRS + AEROCAMARA
10. SALBUTAMOL 2 PUFF SOS
11. SE SOLICITA DE FORMA AMBULATORIO HOLTER DE RITMO Y ECOCARDIOGRAMA
12. PENDIENTE HORA PARA EVALUACIÓN POR NEUROCIRUGÍA
13. CONTROL POST ALTA POLI NEUROLOGIA, REALIZAR IC POST ALTA HODOM
14. ALTA A DOMICILIO CON HODOM + KINESIOLOGIA MOTORA+ RESPIRATORIA
15. SOLICITO ANDADOR SIN RUEDAS

EXÁMENES Y RESULTADOS

26.09.24: crea 0,5, PCR 10, Uremia 63, BUN 29, na+ 136, K+ 4,4, Cl- 103, GA: ph 7,4, PCO2 39,7, pO2 106,2, BE 25,6, FiO2 24%
25.09.24. leucocitos 10900, PCR 10,6, dímero D 350,2, troponina 5,8
ECG x 2 sin cambios agudos, RS
UC negativo
hemoglobina glic 6,4%
TC torax junio 2024: fibrosis pulmonar difusa severa , secuelas TBC apical izquierda,
AngioTc cuello y cerebro /TC cerebro
TSH 2,0, T4L 0,9
B12 841
col total 165, HDL 95, LDL 45, TG 124

Control en: 11 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ LAGOS
MEDICO TRATANTE
15877858-0

JEFE SERVICIO